

Zelo

CHECKPOINT 3 — CONSOLIDAR, VALIDAR E APRESENTAR

Desafio: Burnout Médico: A Dor de Quem Cuida dos Outros (1ª Jornada Incubintech 2026) **Líder:** Maurício Alexandre Barroso | **Nº de integrantes:** 4 integrantes ativos (Raquel Ritter, Mauricio Alexandre, Yasmin, Kati) **Situação no CP2:** Apta

1. Status do Protótipo "Pronto para Palco" (Entregável 1)

Caminho Feliz: o fluxo que vamos demonstrar ao vivo é o ciclo completo pedido pelo edital — **triagem** → **direcionamento** → **follow-up** — mais o diferencial do time. A médica abre o Zelo, faz um check-in de autoavaliação (PHQ-9 ou GAD-7, processado 100% no aparelho) e vê o resultado. Em sinal leve/moderado, ela entra no chat de acolhimento por IA, onde o atalho "falar com uma pessoa real" está sempre visível e leva à escolha entre um par médico anônimo ou um psicólogo — é aqui que mostramos o **chat individualizado e anônimo entre pares**, nosso diferencial validado por entrevista real com médico usuário, e que nenhum concorrente direto oferece combinado com compliance NR-1. Em sinal de risco agudo, o app pergunta o vínculo (SUS ou plano de saúde/rede privada) e mostra o direcionamento certo, com a linha CVV 188 sempre visível. Por fim, o painel do gestor mostra métricas agregadas e anônimas — incluindo a taxa de resposta do follow-up, critério de avaliação que a própria ACM apontou em resposta formal recebida em 19/07.

Limitações Conhecidas: o matching de pares usa perfis fictícios pré-cadastrados, rotulados como demo (curadoria real é processo institucional pós-hackathon). O painel do gestor exibe dados agregados simulados, nunca dados reais de médicos — por desenho de privacidade, não por atraso. O direcionamento SUS/privado usa texto genérico enquanto aguardamos canais específicos da ACM. MBI-HSS segue "em breve" (bloqueio de licenciamento Mind Garden, mapeado desde o CP2). O follow-up é local ao aparelho e não recorrente nesta fase.

Plano de Contingência: vídeo gravado da demo completa como backup, caso a internet ou o servidor falhem ao vivo.

Evidência Visual: o app está publicado — a banca pode testá-lo ao vivo, no próprio celular, em zelo-dusky.vercel.app.

2. Validação da Proposta de Valor (Entregável 2)

Feedback Qualitativo: o Zelo está atualmente em teste com médicos amigos pessoais do time, usando o protótipo de verdade em ambiente real. Já recebemos o retorno de um médico testador com feedbacks concretos: os itens acionáveis foram mapeados no nosso backlog e alguns detalhes serão implementados ainda nesta fase; outros feedbacks apontam para novas features fora do escopo desta primeira entrega da PoC. Sobre usabilidade, esse médico e um pequeno grupo de colegas que também testaram relataram que a aplicação é fácil de usar, com navegação intuitiva, e destacaram que a privacidade evidenciada na experiência é um diferencial para engajamento, assim como alguns aspectos funcionais do produto.

Complementarmente, e de forma mais robusta, tivemos uma validação externa direta e por escrito nesta última semana: encaminhamos ao **demandante do desafio (ACM — Associação Catarinense de Medicina)**

um conjunto de perguntas formais sobre protocolo de crise, escalas de triagem, KPIs prioritários e escopo da PoC. A resposta, recebida em 19/07/2026 (Dr. Marcello Alberton Herdt, Diretor de Inovação), confirmou que nossa arquitetura de triagem (GAD-2/PHQ-2 → GAD-7/PHQ-9) está alinhada ao que se espera, e que **o critério de avaliação da PoC é exatamente a robustez do fluxo triagem → direcionamento → follow-up** — o mesmo fluxo que já era nosso "caminho feliz" de demo.

Ajuste de Rota: essa resposta gerou mudanças reais e documentadas no produto ainda nesta semana:

1. Simplificamos o protocolo de crise — de uma simulação de "conexão ao vivo" com psicólogo para uma tela que sinaliza o risco e direciona corretamente por vínculo (SUS vs. rede privada), já que a ACM confirmou que integração técnica direta não é esperada nesta fase.
2. Adicionamos a métrica de follow-up ao painel do gestor — um requisito que a ACM citou como prioritário e que não existia no nosso backlog até essa resposta.
3. **Mantivemos deliberadamente** o chat anônimo entre pares como diferencial de produto, mesmo não sendo um pedido da ACM — porque nasceu de uma entrevista real com médico usuário (nossa validação mais concreta do medo de falar com IA), e não custava reverter uma decisão já validada.

Proposta de Valor Única: "O Zelo é a única solução que une triagem clínica validada, um atalho sempre visível para falar com uma pessoa real — par médico anônimo ou psicólogo —, e um painel de gestão que transforma bem-estar em compliance NR-1 mensurável, sem que o time de gerência da equipe médica (o hospital contratante da aplicação) tenha acesso à identidade dos médicos, dando segurança e privacidade para eles."

4. Preparação da Equipe (Entregável 4)

Divisão de Fala: Mauricio e Raquel dividem os 4 minutos de apresentação.

Ensaios: já realizamos ensaios cronometrados, ajustados exatamente à janela do edital — 4 minutos de apresentação e 2 minutos de perguntas.

Presença: os 4 integrantes confirmam presença física na final do dia 25/07.